جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : هناء عبدالباقي الديب محمود رضوان
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** الساحل **العنوان :** ممم
رقم البطاقة : 28012210103264 **رقم التليفون :** 01002006261 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 21-12-1980 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: هناء عبدالباقي الديب محمود رضوان
National ID: 28012210103264

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



National ID - Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]



National ID - Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

Name: هناء عبدالباقي الديب محمود **MR. :** 7538	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتها

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها

The patient presented for administration of Zoladex 10.8 mg, Arimidex, and supplemental therapy scheduled for three months.

The patient's disease is staged as clinical T4b N1 M0. Neoadjuvant chemotherapy (NACTH) was previously administered, and radiotherapy to the right breast was completed in June 2022. A port was placed, and the current regimen includes aromatase inhibition with Arimidex, GnRH agonist therapy with Zoladex, and bone protection with Zometa.

The patient is undergoing treatment for right-sided breast cancer, clinical stage T4b, with no distant metastases. Pathology reports indicate ER-positive, PR-positive, HER2-negative disease (ER 23+). The treatment plan includes radiotherapy to the right breast, continuation of the port, Zoladex, Arimidex, and Phesgo, with follow-up imaging and laboratory studies ordered to assess response and monitor for weight loss and abdominal pain. New CT scans and labs are pending for evaluation of Zometa, Zoladex, and Arimidex therapy.

Follow-up imaging of the right axillary lymph nodes shows preserved hilum with a 10 × 5 mm node. The plan is to continue follow-up with right axillary ultrasound and contrast-enhanced CT of the chest, abdomen, and pelvis, and to maintain therapy with Zoladex, Arimidex, and supplemental treatment for three months.

تحريرا في ,

التاريخ :	**19-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : **Reham Ahmed Fathy Ibrahim**

يعتمد ,

Patient Name	:الأستاذه / هناء عبدالباقى الديب محمود رضوان	Request No.	: 13001897
Patient No.	:28012210103264	Request Date	: 20/06/2022
Path No.	:1722/0222	Verification Date	: 05/07/2022
Sex	:Female	Financial Category	: اورام مار السلام - تغطية الدولة
Age	:41 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: dr.Enas

Pathology Report

Clinical data:
Right breast cancer, post NACT

Nature of specimen:
1) Right simple mastectomy & SLNB specimens
Taken at 20/6/2022

Gross examination:
1- Right SLN: 2 fibro fatty tissue piece measured 4x3 cm collectivelly , entangling 3 nodules up to 0.5 cm.
2- Right simple mastectomy specimen measured 22x21x3 cm , with covering skin elipse measured 20x12 cm
- Tumor extent
o Number: An ill defined rubbery gryish white tumor bed site
o Size: 3.5x2.5x2 cm
o Skin involvement: Free grossly
- Distance from margins: 1.5 cm from deep margin

Microscopic examination:
Pathologic complete responce in a previously diagnosed invasive carcinoma.
- Ductal carcinoma in situ: No
- Skin involvement: Free nipple & areola
- Lymph node involvement: Free SLNs (0/3)
- Angio invasion: No
- Perineural invasion: No
- Resection Margins: Free deep margin

Diagnosis:

Verified by :
dr.esraa magdy

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

MDT FORM

11/8/2022

Name	ضناء عبد الباقي الديب	MRN	
Age	41 yrs	ID	٢٨١٠١٠١٢٢٠٤٢
Menopausal status		Phone	٠١٠٢٠٠٦٢٦١
OCP		marital status	
Co morbidity		Family history	

Clinical Data

Bx: IDC

ER:	PR:	HER 2:	KI67:
8/8	8/8	3+	

Sonomammography:
- cT4b, N0M0.

→ TCHP x 6 cycles

Mets Workup:

R / L

R/ SM+ SLNBx → 20-6-2022

TNM

Recommendations:
- ypT0, ypN0
- SLNBx (0/3)
- Free margins.

MDT OUTCOME & PLAN

In view of pathological complete Response:

→ To cont Herceptin + pegfilgrastim up to 17 cycles.
- AI + Zoladex
- PORT
- Follow up

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY

SIGNATURE

Patient Name	:الأستاذه / هناء عبدالباقى الديب محمود رضوان	Request No.	:135394
Patient No.	:28012210103264	Request Date	:28/12/2021
Path No.	:SR-772/21	Verification Date	:30/12/2021
Sex	:Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	:41 Y	Department	:Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	:.marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Breast cancer
Nature of the specimen:
Slide revision
Gross Examination:
One block (9634/21)& three stained slides

Microscopic examination:
- Histological type: IDC
- Grade II
- Angioinvasion: inconspicous
- Ductal carcinoma in situ: positive

Diagnosis:
Rt breast cancer, slide revision:
- Invasive duct carcinoma GII
- Biomarkers:

o ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)
o PR: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)
o Her2:strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+)

Prof. Gamal Abdelaty
Dr.Rana Fathy

Verified by :
Rana fathy

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (237) - كورنيش النيل - ميت عقبة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 237- Nile Corniche - Mit Ei Qadreia- Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Hanaa Abd Al Baky Al Deeb Mahmoud	Date : 30/05/2022
Exam : C.T. ABDOMEN &PELIVS WITH CONRAST	Age : 41 Year(s)
Medical ID: rt breast cacer under chemoherapy ,, last study dated 5-12-2021 attached	

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

1. ***Chest:***

- Compared to the previous ct study dated 5-12-2021
- Regression of the right breast UOQ enhancing lesion as well as related right breast skin thickening.
- Still seen right axillary prominent subcentimetric lymph nodes.
- No sizable pulmonary nodules.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. ***Abdomen and pelvis:***

- The liver is average in size with stable segment IVa hypodense focal lesion measuring 6 mm.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Still seen fibroid uterus.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

3. ***The scanned skeleton:***

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Hanaa Abd Al Baky Al Deeb Mahmoud	Date : 30/05/2022
Exam : C.T. ABDOMEN &PELIVS WITH CONRAST	Age : 41 Year(s)
Medical ID: rt breast cacer under chemoherapy ,, last study dated 5-12-2021 attached	

- Still seen manubrium sterni sclerotic lesions.
- L1 lower VEP subchondral cyst measuring 7 mm.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

OPINION:

- ***Regression of the right breast malignant looking mass lesion.***
- ***Rather stationary course of the rest of the study.***

Dr.Mohammed Mohsen, MSc.

Dr.M. Gomaa, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]